

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

CUESTIONARIO DE AGRESIÓN REACTIVA Y PROACTIVA (RPQ)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Diferencial de Agresión Impulsiva versus Instrumental

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Cuestionario de Agresión Reactiva y Proactiva (RPQ).
Nombre Original (Inglés)	<i>Reactive-Proactive Aggression Questionnaire (RPQ)</i>
Autores Originales	Adrian Raine, Kenneth Dodge, Rolf Loeber, Lise Gatzke-Kopp, Don Lynam, et al. (2006).
Adaptaciones Españolas	Andreu, Peña y Ramírez (2009, AEPCP); Cima et al. (2013).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación de conducta agresiva infanto-juvenil y forense.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 23 reactivos politómicos de 3 opciones de frecuencia (0 = Nunca, 1 = A veces, 2 = A menudo).
Población y Rango	Adolescentes y jóvenes (11 a 20 años). Población escolar, centros de menores, clínica y justicia juvenil.
Tiempo de Administración	5 a 8 minutos.
Régimen de Licencia	Acceso abierto (Open Access AEPCP). Libre uso para fines clínicos y de investigación no comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y NEUROBIOLOGÍA DE LA AGRESIÓN

El RPQ fue desarrollado por Adrian Raine y colaboradores (2006) para dar respuesta a la necesidad criminológica y clínica de descomponer el constructo heterogéneo de la agresión en dos subtipos etiológicamente y funcionalmente disociables: la agresión **reactiva** y la agresión **proactiva**.

Desde el paradigma de la neurociencia afectiva, la **agresión reactiva** es una respuesta de “furia caliente”, impulsiva y desregulada ante una provocación real o percibida, caracterizada por hiperreactividad amigdalina y fallos en el control inhibitorio de la corteza prefrontal orbitofrontal. En contraste, la **agresión proactiva** es “fría”, instrumental, predatoria y planificada, dirigida a obtener beneficios tangibles (dinero, estatus, dominancia grupal) sin provocación previa, fuertemente asociada a rasgos de dureza e insensibilidad afectiva (*callous-unemotional traits*) e hiporreactividad fisiológica autonómica.

3. SUBESCALAS DEL CUESTIONARIO RPQ (RAINE ET AL., 2006)

Subescala RPQ	Ítems	Rango Dir.	Contenido y Significación Psicológica
1. Agresión Reactiva	1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 20	0 a 22	Reacciones de cólera explosiva ante burlas, gritos al ser provocado, golpes reactivos tras ser golpeado y pérdida de control.
2. Agresión Proactiva	2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23	0 a 24	Intimidación deliberada para conseguir cosas, amenazas calculadas, peleas premeditadas y crueldad instrumental.
PUNTUACIÓN TOTAL RPQ	1 al 23	0 a 46	Índice acumulativo general de conducta agresiva violenta durante la adolescencia.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO PSICOMÉTRICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente fiabilidad en la adaptación española de Andreu et al. (2009): alfa de Cronbach de 0.84 para Agresión Reactiva, 0.83 para Agresión Proactiva y 0.89 para la Escala Total.
Estructura Factorial	El Análisis Factorial Confirmatorio refrenda la superioridad del modelo bifactorial correlacionado ($r = 0.65$ entre ambas formas) sobre modelos unidimensionales (RMSEA = 0.048, CFI = 0.95).
Validez Discriminante	La agresión reactiva correlaciona específicamente con impulsividad motora, hostilidad y neuroticismo, mientras que la proactiva se asocia selectivamente con delincuencia y psicopatía.
Estabilidad Temporal	Fiabilidad test-retest $r = 0.76$ a 0.82 tras un intervalo de 6 semanas en muestras educativas y clínicas juveniles.
Invarianza de Género	Invarianza estructural verificada en varones y mujeres, si bien los varones puntúan sistemáticamente más alto en agresión proactiva.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y PUNTUACIÓN DE ÍTEMS

Cada afirmación evalúa la frecuencia de la conducta descrita mediante una escala ordinal de 3 puntos:

- **0** = Nunca | **1** = A veces | **2** = A menudo.
- **Subescala Reactiva (11 ítems)**: Suma de ítems 1, 3, 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 20. Rango: **0 a 22 puntos**.
- **Subescala Proactiva (12 ítems)**: Suma de ítems 2, 4, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 23. Rango: **0 a 24 puntos**.
- **Puntuación Total RPQ (23 ítems)**: Suma directa de las dos subescalas. Rango global: **0 a 46 puntos**.

6. BAREMOS Y ESTRATIFICACIÓN EN ADOLESCENTES (ANDREU ET AL., 2009)

Percentil	Nivel	Estado Conductual	Conducta Asistencial / Educativa
< P75	Bajo/ Medio	Conducta prosocial adaptativa	Patrones normales de resolución de conflictos interpersonales. Fomento de habilidades socioemocionales.
P75 – P89	Moderado	Zona de riesgo / Agresividad incipiente	Episodios frecuentes de confrontación. Intervención psicoeducativa escolar en autocontrol y empatía.
P90 – P94	Elevado	Riesgo Clínico / Conductual Significativo	Disfunción relacional severa o conducta disruptiva. Evaluación clínica en salud mental y orientación familiar.
>= P95	Extremo	Alerta Conductual Grave / Disocial	Elevadísimo riesgo de agresiones lesivas y conductas delictivas. Tratamiento multimodal y coordinación forense.

ASIMETRÍA NORMATIVA EN AGRESIÓN PROACTIVA: En población comunitaria, la agresión proactiva presenta una distribución muy asimétrica con una mediana cercana a 0 o 1 punto. Cualquier puntuación *ge5* puntos en la subescala proactiva sitúa al adolescente por encima del percentil 90, indicando una conducta predatoria patológica de alto riesgo criminológico.

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DE INTERVENCIÓN

DISEÑO TERAPÉUTICO BASADO EN EL SUBTIPO DE AGRESIÓN:

- **Predominio de Agresión Reactiva:** Sesgo de atribución hostil y desregulación afectiva; el menor percibe ataques donde no los hay. Tratamiento de elección: entrenamiento en relajación psicofisiológica, reatribución cognitiva y técnicas de tiempo fuera (*timeout*).
- **Predominio de Agresión Proactiva:** Ausencia de empatía y reforzamiento instrumental de la intimidación. Las técnicas tradicionales de relajación o autoafirmación son ineficaces o contraproducentes; se requiere modificación estricta de contingencias ambientales, entrenamiento en empatía inducida y sanción reparadora ineludible.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: INTERVENCIÓN EN JUSTICIA JUVENIL

Paciente: Varón de 15 años, derivado por el equipo técnico de la fiscalía de menores tras un altercado en un centro comercial con agresión física y robo de teléfono móvil a un compañero de instituto.

Resultados RPQ:

• **Puntuación Total:** 24/46 (Percentil > 95 — Muy Elevado).

• **Desglose factorial:** Agresión Proactiva = 11/24 (> P95; puntuaciones elevadas en usar la fuerza para que otros hagan lo que él quiere y planear peleas); Agresión Reactiva = 13/22 (P90; perder el control rápidamente al ser increpado).

Conducta Asistencial: Se concluye la existencia de un Trastorno de la Conducta de inicio adolescente con patrón mixto agresivo y rasgos de insensibilidad emocional en estudio. Se establece un programa de intervención judicial en medio abierto consistente en mediación penal juvenil con reparación del daño a la víctima, supervisión contingente familiar y entrenamiento específico en toma de perspectiva afectiva. A los 6 meses de intervención, el RPQ descendió a 9/46, sin reincidencia delictiva.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y EXPLORACIÓN COMPLEMENTARIA

ALERTA: PORTE DE ARMAS Y DAÑO LETAL

Puntuaciones máximas en los reactivos proactivos 12 y 18 (utilizar armas o amenazar gravemente) requieren activación inmediata de protocolos de salvaguarda, aviso a servicios de protección e inspección cautelar.

COMORBILIDAD CON CONSUMO DE TÓXICOS

La agresión reactiva severa suele exacerbarse drásticamente bajo los efectos del alcohol o cannabis; es preceptivo realizar cribado toxicológico paralelo (CRAFT / CAST).

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Raine, A., Dodge, K., Loeber, R., Gatzke-Kopp, L., Lynam, D., Reynolds, C., Stouthamer-Loeber, M., & Liu, J. (2006). The Reactive-Proactive Aggression Questionnaire: differential correlates of reactive and proactive aggression in adolescent boys. *Aggressive Behavior*, 32(2), 159–171.
2. Andreu, J. M., Peña, M. E., & Ramírez, J. M. (2009). Cuestionario de agresión reactiva y proactiva: un instrumento de medida de la agresión en adolescentes. *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 14(1), 37–49.
3. Cima, M., Raine, A., Meesters, C., & Popma, A. (2013). Validation of the Children's Reactive and Proactive Aggression Questionnaire in Dutch juvenile delinquents. *Psychiatry Research*, 208(1), 78–82.
4. Dodge, K. A. (1991). The structure and function of reactive and proactive aggression. In D. J. Pepler & K. H. Rubin (Eds.), *The development and treatment of childhood aggression* (pp. 201–218). Lawrence Erlbaum Associates.